

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT



刘小华(男)

项目号 U052110011

单位 京东自营

联系电话 186****6867

项目简称 京东自营

员工号

类别 散客

卡号 1111000168191098

部门

递送地址

递送方式 电子报告

体检号 9320230401273



上海爱康国宾健之维门诊部

检查日期 2023.04.01

46/2191

爱康国宾®

360°健康全管理

爱康集团是中国领先的中高端连锁体检与健康管理集团，通过旗下多个品牌，为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老等健康管理与医疗服务。截止2022年8月，爱康集团（包括并购基金）已在59大城市设有155家体检与医疗中心。同时爱康集团与全国200多个城市超过800家医疗机构建立合作网络。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



扫码下载爱康APP

www.ikang.com

目录

CONTENTS

1	体检重要异常结果、复查建议及治疗建议	04
	异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案	
2	专家建议与指导	05
	建议与指导	
3	健康体检结果	07
	检查详细结果	
4	口腔检查结果	15
	口腔健康整体解决方案/建议	
5	历年主要异常指标对比	16
	历年数据对比及健康预测	
6	医学名词科普知识	18
	医学名词科普知识内容	

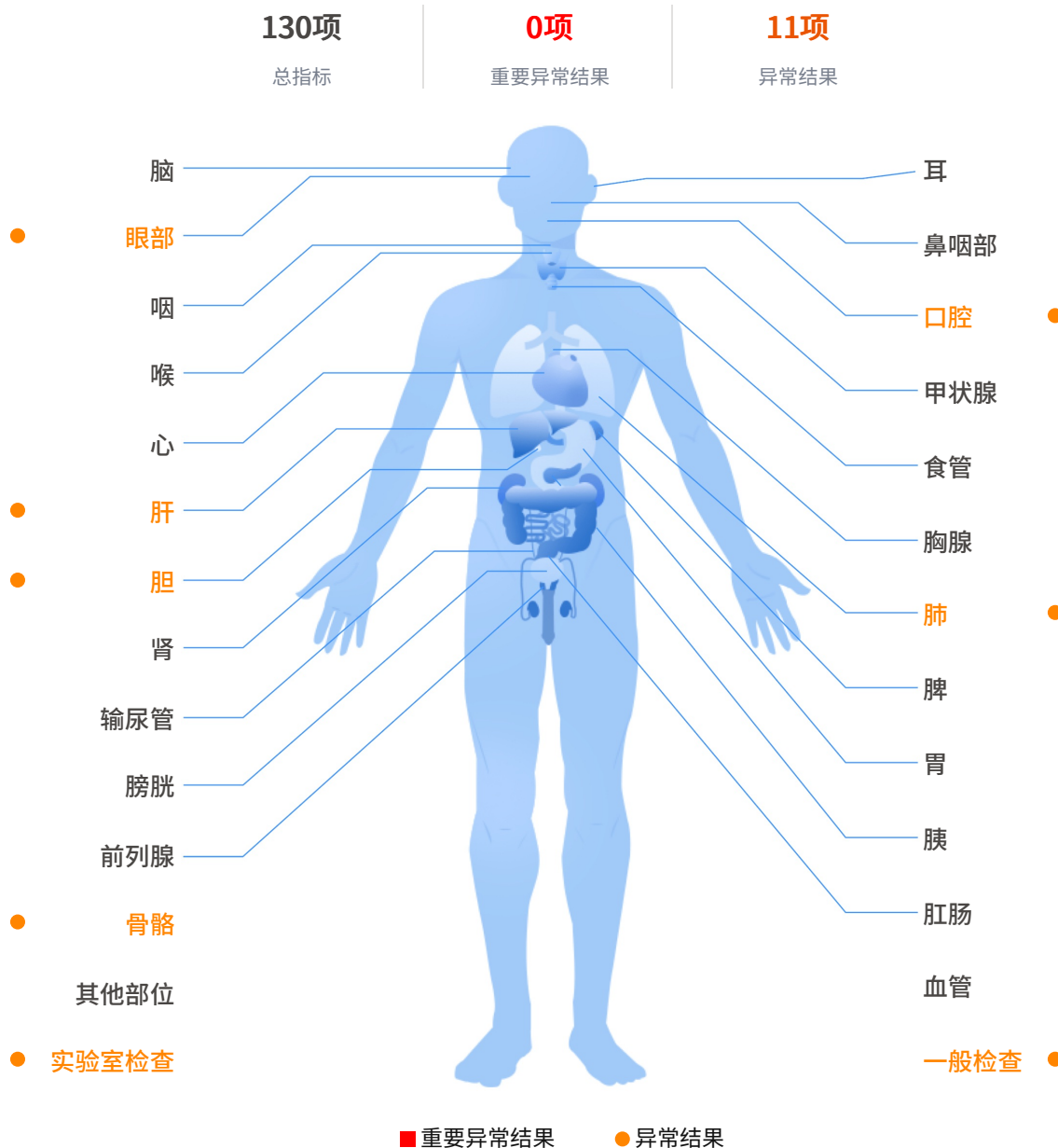
尊敬的刘小华先生，您好！

上海爱康国宾健之维门诊部感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2023年04月01日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

1. 您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2. 健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3. 您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4. 因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5. 由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

- 【1】 体重指数增高
- 【2】 肺纹理增多
- 【3】 γ -谷氨酰转移酶增高
- 【4】 甘油三酯增高
- 【5】 轻度脂肪肝
- 【6】 肝囊肿
- 【7】 胆囊息肉样病变
- 【8】 胆囊壁欠光滑
- 【9】 上胸椎轻度侧弯表现
- 【10】 腰椎轻度骨质增生(下腰椎轻度向左侧弯)
- 【11】 屈光不正



下载爱康APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 体重指数增高

- 1、体重指数（体重(kg)÷身高(m)的平方）≥24为超重，≥28为肥胖。
- 2、饮食宜低脂肪、低糖、低盐，控制主食量，辅以适量优质蛋白（鱼、蛋、奶类等）以及各种蔬菜。
- 3、加强运动消耗多余脂肪。可依年龄及身体状况，选择适合自己的运动方式和运动时间，以达到减轻体重的目的。
- 4、推荐运动三要素，频率：每周至少三次；强度：心率达到（170-年龄）次/分；时间：平均每次半小时以上。运动以微汗为宜。

02 肺纹理增多

- 1、常见于急性或慢性支气管疾患。
- 2、尽量避开烟雾环境，杜绝主动吸烟，减少被动吸烟；避开过敏物，保暖，防止伤风感冒。
- 3、若出现咳、喘、痰多等症状，请到医院呼吸内科诊治。

03 γ-谷氨酰转移酶增高

- 1、肝胆疾病可以引起γ-谷氨酰转移酶增高，此外，γ-谷氨酰转移酶对酒精敏感。
- 2、建议一个月后复查，如持续增高，请到消化内科诊治。

04 甘油三酯增高

- 1、建议限酒，低脂、低胆固醇饮食，如少吃油腻及煎烤类食物，少吃动物内脏等，多食蔬菜水果。加强运动，促进脂质代谢。
- 2、每3-6个月复查血脂和肝脏B超一次，复查前请低脂饮食3天。如血脂持续增高，请在医生指导下使用调脂药物。

05 轻度脂肪肝

- 1、是肝细胞中脂肪沉着蓄积超过生理含量，程度较轻。
- 2、加强体育锻炼，如：跑步、散步、健美操、打太极拳等，促进脂质代谢。
- 3、建议定期复查，如有肝功能异常消化内科就治疗。

06 肝囊肿

肝囊肿（单发或多发）。随年龄增长检出率亦增加，如无症状,建议定期复查。若直径大于50毫米，或有症状者、逐渐增大者等，请及时专科诊治。

07 胆囊息肉样病变

- 1、是指来源于胆囊粘膜凸入胆囊腔内的突起性病变，它既包含胆囊的炎症性或代谢性增生疾病，也包含胆囊良、恶性肿瘤。
- 2、建议进一步检查明确诊断。

08 胆囊壁欠光滑

平日低脂肪、低胆固醇饮食，规律就餐，定期复查B超。若有不适，到医院消化内科进一步诊治。

09 上胸椎轻度侧弯表现

9088EF6C8A021C98942E79F7BDE9EB2F417F8FE44B4E4A75B8130FC397D190D3 9088EF6C8A021C98942E79F7BDE9EB2F417F8FE44B4E4A75B8130FC397D190D3

上海爱康国宾健之维门诊部

全国统一报告解读专线：400-081-8899

注：★ 自费增项

5 / 20



下载爱康APP
查看彩色报告

- 1、分为先天性和特发性。
- 2、建议到医院专科进一步咨询和诊治。

10 腰椎轻度骨质增生(下腰椎轻度向左侧弯)

- 1、若无症状，不需特殊处理，适度活动腰部，建议睡硬板床。
- 2、若出现下肢呈放射性麻木、疼痛时，请及时到医院骨科就诊，建议做CT检查，排除腰椎间盘突出。

11 屈光不正

注意用眼卫生，定期眼科随访。

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者：杨建华

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	175.0	cm		
体重	78.2	Kg		
体重指数	25.5		↑	18.5—23.99
收缩压	106	mmHg		90.0—139.0
舒张压	66	mmHg		60.0—89.0

初步意见

体重指数增高

内科

检查者：蒋丽娟

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	74	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	

初步意见

未见明显异常

外科

检查者：任建中

检查项目	检查所见	单位
------	------	----



皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
外生殖器	放弃检查	
肛门、直肠指诊	放弃检查	
前列腺(外科)	放弃检查	
外科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

眼科

检查者：高筱芬、向玉兰

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)		
裸视力(左)		
矫正视力(右)	1.0	
矫正视力(左)	1.0	
色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
初步意见	屈光不正	

耳鼻咽喉科

检查者：黄妙英

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	

外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

血常规

操作者：管祥生 审核者：刘秀英

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	5.30		3.5—9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	5.37		4.3—5.8	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	160.0		130—175	g/L
红细胞比容	HCT	0.49		0.4—0.5	L/L
平均红细胞体积	MCV	91.00		82—100	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	29.80		27.0—34.0	fL
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	326.00		316—355	pg
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	13.30		11—16	%
血小板计数	PLT	236.00		125—350	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	7.60		7.0—13.0	fL
血小板分布宽度	PDW	13.30		10—20	%
淋巴细胞百分比	LYMPH%	31.70		20—50	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	58.40		40.0—75.0	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.68		1.1—3.2	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	3.10		1.8—6.3	10 ⁹ /L
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	44.00		35—54	g/L

血小板压积	PCT	0.179		0.108—0.282	%
单核细胞百分比	MONO%	7.80		3.0—10.0	%
单核细胞绝对值	MONO	0.41		0.1—0.6	10^9/L
嗜酸性细胞百分比	EOS%	2.00		0.4—8.0	%
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.11		0.02—0.52	10^9/L
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.10		0—1.0	%
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.01		0—0.06	10^9/L

小结	未见明显异常
----	--------

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者：王乐萍 审核者：刘秀英

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.015		1.010—1.025	
尿酸碱度	PH	7.0		4.5—8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL
尿镜检红细胞	RBC	0		0—3	
尿镜检白细胞	WBC	0		0—5	/HP
管型	CAST	0			
尿液透明度	UCI	清			
尿液颜色	Colour	淡黄			

尿液其它		无			
小结	未见明显异常				

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者：罗焱焱 胡文芳 审核者：翟红礼 刘芳

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
★ 碱性磷酸酶	ALP	82		42—141	U/L
丙氨酸氨基转移酶	ALT	36		0—50	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	19		15—40	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	133	↑	10—60	U/L
尿素	UREA	5.9		2.5—7.2	mmol/L
肌酐	Cr	52		44—106	umol/L
尿酸	UA	345		208—428	umol/L
空腹血糖	FBG	5.28		3.9—6.1	mmol/L
总胆固醇	TC	5.16		3.1—5.7	mmol/L
甘油三酯	TG	1.95	↑	0.45—1.7	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.54		0.8—1.8	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	2.92		0—3.37	mmol/L
磷酸肌酸激酶	CK	67.00		50—310	U/L
磷酸肌酸激酶同工酶	CK-MB	8.00		0—24	U/L
乳酸脱氢酶	LDH	137		90—250	U/L
幽门螺杆菌抗体	Hp-Ab	4.5		0—15	AU/mL
甲胎蛋白（T-12）	AFP	3.76		0—20	ng/ml
癌胚抗原（T-12）	CEA	1.34		0—5	ng/ml
糖类抗原19-9（T-12）	CA19-9	8.13		0—37	u/ml
糖类抗原242（T-12）	CA242	4.96		0—20	u/ml
糖类抗原125（T-12）	CA125	10.03		0—35	u/ml

细胞角蛋白19片段 (T-12)	CYFRA21-1	1.11		0—5	ng/mL
神经元特异性烯醇化酶 (T-12)	NSE	18.51		0—25	ug/L
总前列腺特异性抗原 (T-12)	T-PSA	1.44		0—4	ng/ml
游离前列腺特异性抗原 (T-12)	f-PSA	0.30		0—1	ng/ml
胃蛋白酶原 I (T-12)	PG I	135.38		70—250	ng/ml
胃蛋白酶原 II (T-12)	PG II	7.17		0—28	ng/ml
人绒毛膜促性腺激素游离β亚基 (T-12)	free-β-hCG	0.23		0—4	ng/ml
PGI/PGII(T-12)	PGI/PGII(T-12)	18.88		3—100	
F-PSA/T-PSA(T-12)	F-PSA/T-PSA(T-12)	0.21		0.15—1.0	

小结	1.甘油三酯增高 2.γ-谷氨酰转移酶增高
----	--------------------------

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

检查者：

检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律 正常心电图	

初步意见	未见明显异常
------	--------

超声检查室

检查者：梅一萍

检查项目	检查所见	单位
肝	肝脏形态大小正常，肝内实质回声细腻，分布欠均匀，血管纹理走行清晰，门静脉正常。CDFI:血流显示正常； 肝右叶可见无回声区，边界清楚，大小约11×9mm。CDFI:血流显示正常；	
胆	胆囊形态大小正常，囊壁欠光滑，胆汁充盈良好，胆总管内径正常，胆囊壁可见偏强回声，大小约4×3mm，后方无声影，胆汁充盈尚可，胆总管内径正常。	

胰	胰腺形态大小正常，内部回声分布均匀，主胰管未见扩张.CDFI: 血流显示正常	
脾	脾脏形态大小正常，包膜完整光滑，内部回声分布均匀，脾门血管正常	
双肾	双肾形态大小位置正常，包膜完整，实质回声正常。CDFI：血流显示正常	
前列腺	前列腺形态大小正常，包膜清晰，内部回声均匀	
甲状腺	双侧甲状腺形态大小正常，表面光滑，包膜完整，内部回声均匀。CDFI：血流显示正常。	
初步意见	1.轻度脂肪肝 2.肝囊肿 3.胆囊壁欠光滑 4.胆囊息肉样病变	

放射科

检查者：朱亚辉 审核者：

检查项目	检查所见	单位
胸部	两侧肺野透亮度正常。两下肺纹理增多。两肺门无增大。双膈面光整，肋膈角清晰锐利。心影大小形态未见异常。纵隔居中，无增宽。上胸椎轻度侧弯表现。	
腰椎	腰椎椎体序列正常，腰椎前缘部分椎体轻度增生，附件未见异常。椎间隙未见异常。正位片示下腰椎轻度向左侧弯，腰5椎体左侧横突与髂骨形成假关节。	
初步意见	1.双下肺纹理增多（上胸椎轻度侧弯表现） 2.腰椎轻度骨质增生（下腰椎轻度向左侧弯）	

主检医师：

孙玉蓉

iKang 爱康



扫码下载爱康APP

想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理

约体检

查报告

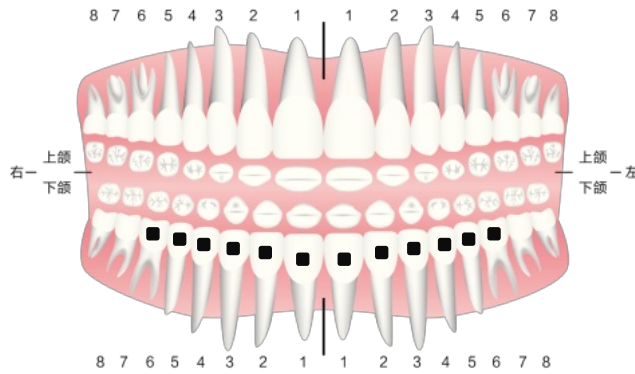
历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

4.口腔检查结果



口腔腺体

1、未见明显异常

牙列

1、未见明显异常

唇

1、未见明显异常

牙体★

1、楔状缺损:左下:
【1,2,3,4,5,6】 右下:
【1,2,3,4,5,6】

牙周

1、未见明显异常

舌

1、未见明显异常

腭

1、未见明显异常

口腔粘膜

1、未见明显异常

颞下颌关节

1、未见明显异常

口腔科其它

1、未见明显异常

口腔健康整体解决方案/建议

操作者: 葛哲虎

结论	建议
楔状缺损	楔状缺损: 1、是牙齿唇、颊侧颈部硬组织发生缓慢消耗所致的缺损。2、当缺损少无牙本质过敏时, 无需特殊处理; 缺损较大时, 建议到口腔内科实行充填治疗。3、改正不良刷牙习惯, 避免拉锯式横刷, 并选用较软的牙刷和颗粒较细的牙膏。

牙齿护理知识

- 定期洁牙, 提倡每半年或一年洁牙一次, 定期清洁牙石, 预防牙周疾病的发生。
- 不要用牙齿咬坚硬的物品, 以防止外伤。
- 正确合理的刷牙方式是保护牙齿的最佳方法。
- 建议定期去齿科医院进行检查, 养成看牙医的习惯, 早点治疗可以避免病情恶化或导致全身其他疾病的发生。



齿科咨询热线

4006-190-920



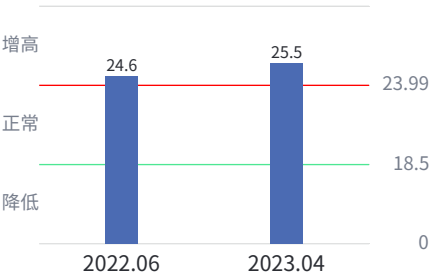
看齿科 来爱康

5. 历年主要异常指标对比及健康指标预测

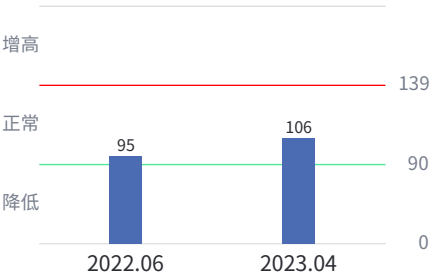
一般项目检查

检查项目	测量结果		单位	参考区间
	2022年06月	2023年04月		
体重指数	24.6	25.5		18.5-23.99
收缩压	95	106	mmHg	90.0-139.0
舒张压	72	66	mmHg	60.0-89.0

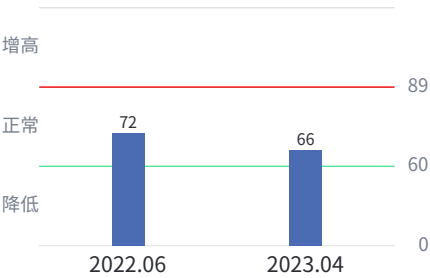
体重指数



收缩压 (mmHg)



舒张压 (mmHg)



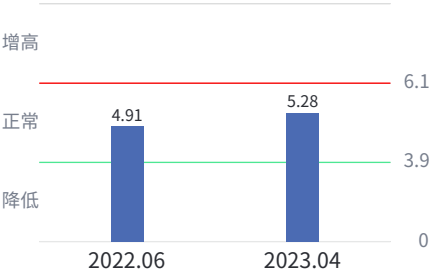
实验室检查

检查项目	测量结果		单位	参考区间
	2022年06月	2023年04月		
空腹血糖	4.91	5.28	mmol/L	3.9-6.1
总胆固醇	4.31	5.16	mmol/L	3.1-5.7
低密度脂蛋白胆固醇	2.43	2.92	mmol/L	0-3.37

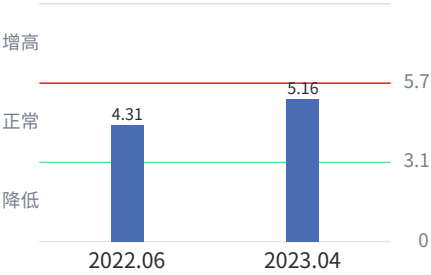


下载爱康APP
查看彩色报告

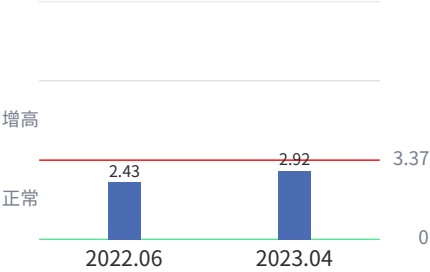
空腹血葡萄糖 (mmol/L)



总胆固醇 (mmol/L)



低密度脂蛋白胆固醇 (mmol/L)



6.医学名词科普知识

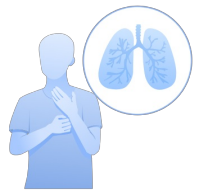
医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

什么是甘油三酯？



常有人将血脂与甘油三酯视为一体，实际上，甘油三酯（TG）仅是血脂的一种，血脂还包括其他物质如胆固醇等。当病人的血甘油三酯特别高（颗粒大、密度低的脂蛋白过多）时，血液会呈乳白色，将这种血静置一段时间后，血的表面会形成厚厚的一层奶油样物质，这便是化验单上报告的所谓的“甘油三酯”。甘油三酯的功能与胆固醇截然不同，甘油三酯是人体主要的能量储存库。尽管甘油三酯有诸多生理功能，但凡事物极必反，过多的甘油三酯会导致脂肪细胞功能改变和血液粘稠度增加，并增加患冠心病的危险性，而且，血液中甘油三酯过高还会引起急性胰腺炎。

什么是肺纹理？



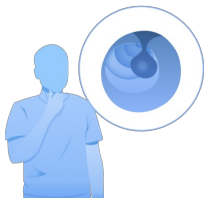
由肺动脉和肺静脉组成，支气管壁、淋巴和少量间质组织也参与肺纹理形成。正常情况下肺纹理自肺门向外围肺野逐渐减少变淡，管径依次缩小，分布渐次稀疏，至肺外带不易辨清。肺纹理多少、粗细与个体差异、呼吸状态有关。异常肺纹理阴影结构紊乱、粗细不均、边缘模糊、密度增高，在某种程度上能反映肺血流量和心脏功能的情况，对诊断某些呼吸系统、循环系统疾病有一定的帮助。

什么是体重指数？



目前常用的体重指数（body mass Index）简称BMI，又译为体质指数。在判断肥胖程度时，使用这个指标的目的在于消除不同身高对体重指数的影响，以便于人群或个体间比较。研究表明，大多数个体的体重指数与身体脂肪的百分含量有明显的相关性，能较好地反映机体的肥胖程度。但在具体应用时还应考虑到其局限性，如对肌肉很发达的运动员或有水肿的病人，体重指数值可能过高估计其肥胖程度。老年人的肌肉组织与其脂肪组织相比，肌肉组织的减少较多，计算的体重指数值可能过低估计其肥胖程度。相等BMI值的女性的体脂百分含量一般大于男性。同时测定体脂百分含量（体脂%）会有助于判断肥胖程度。

什么是息肉？

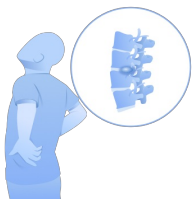


在致炎因子或某种其他因素长期刺激下，局部粘膜上皮、腺体及肉芽组织增生形成。一般发生在消化道、呼吸道、泌尿道等腔道器官内。它自粘膜表面向管腔内突出形成肉样肿块。息肉大小不等，表面光滑，一般无乳头生成，有的可伴有水肿、继发感染和溃疡形成。按发生原因，息肉可分为增生性和腺瘤性两类。增生性息肉又称炎性息肉，即通称的“息肉”。腺瘤性息肉可为新生的肿瘤，多属良性。



下载爱康APP
查看彩色报告

什么是骨质增生?



骨关节边缘或其邻近软组织的唇样或角样增生钙化、关节面及骨突处骨小梁增多和骨密度增高的一类病变。因有时其形状像口唇或像鸟嘴，故也叫做唇状突起、骨赘或骨刺。多见于中老年人，其实质并非钙化加强而是一种骨骼的退行性病变。多数患者无临床症状，少数因增生骨质压迫神经或邻近软组织而产生疼痛等症状。

什么是γ-谷氨酰转移酶?



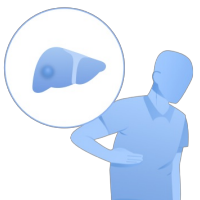
γ-谷氨酰转移酶(γ-GT)是谷氨酰循环的重要酶系之一，参与氨基酸的吸收、转运及利用等。由于γ-GT主要来源肝脏，因此γ-GT活性升高是诊断肝脏疾病生化指标之一。在心血管疾病中测定γ-GT活性变化，主要用于判断急性心肌梗死(AMI)后梗死部位心肌修复情况，以及对心功能不全的诊断等。

什么是屈光不正?



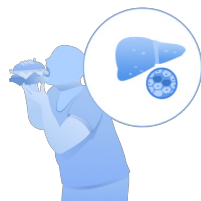
在调节松弛的状态下，正视状态的眼球(正常屈光)，入射光线经过角膜、晶状体后聚焦于视网膜表面，形成清晰的图像传入大脑。晶状体具有弹性，年轻人的弹性更好。调节时，睫状肌调整晶状体形状以更好的聚焦影像。屈光不正是指眼在调节松弛的状态下，平行光线经过眼的屈光系统屈折后，不能把光线聚焦成清晰的图像在视网膜上，而成像于视网膜前或后，造成眼视物模糊。屈光不正包括远视、近视和散光。屈光不正的主要症状为视远和(或)视近时视物模糊。有时候，睫状肌张力过高可能引起头痛症状。偶尔，长时间注视可能导致眼表面干燥，引起眼部刺激症状、眼痒、视觉疲劳、异物感和眼红。儿童表现为阅读时皱眉和过度眨眼或者揉眼。矫治近视眼需配戴合适度数的凹透镜，使平行光线在进入眼以前发散，经眼屈光系统后聚焦于视网膜上。同理，矫治远视眼需配戴合适度数的凸透镜，矫治散光需配戴柱镜或球柱镜。散光眼即使度数很轻，若有视力下降，或出现视疲劳症状者，都应当配戴矫正眼镜。对于高度散光眼或不规则散光眼，当镜片无法矫治时可以考虑配戴硬性接触镜或行准分子激光手术治疗。

什么是肝囊肿?



由各种致病因素使肝脏出现囊性病变的一组疾病，是一种较常见的肝脏良性疾病。可分为寄生虫性或非寄生虫性肝囊肿。前者以肝包虫病为多见；后者可分为先天性、创伤性、炎症性及肿瘤性囊肿，以先天性肝囊肿为多见。狭义肝囊肿指先天性肝囊肿，起源于肝内迷走的胆管。临床上可分为单发性肝囊肿和多发性肝囊肿，病程缓慢，可出现肝区胀痛、不适及压迫症状，如黄疸、肠梗阻等。B超是首选检查方法，CT也有助诊断。一般无症状或囊肿较小者无须手术治疗；囊肿较大或出现压迫表现应给予适当的治疗，手术方法有囊肿穿刺抽液术、囊肿开窗术、囊肿引流术或切除术等。

■ 什么是脂肪肝？



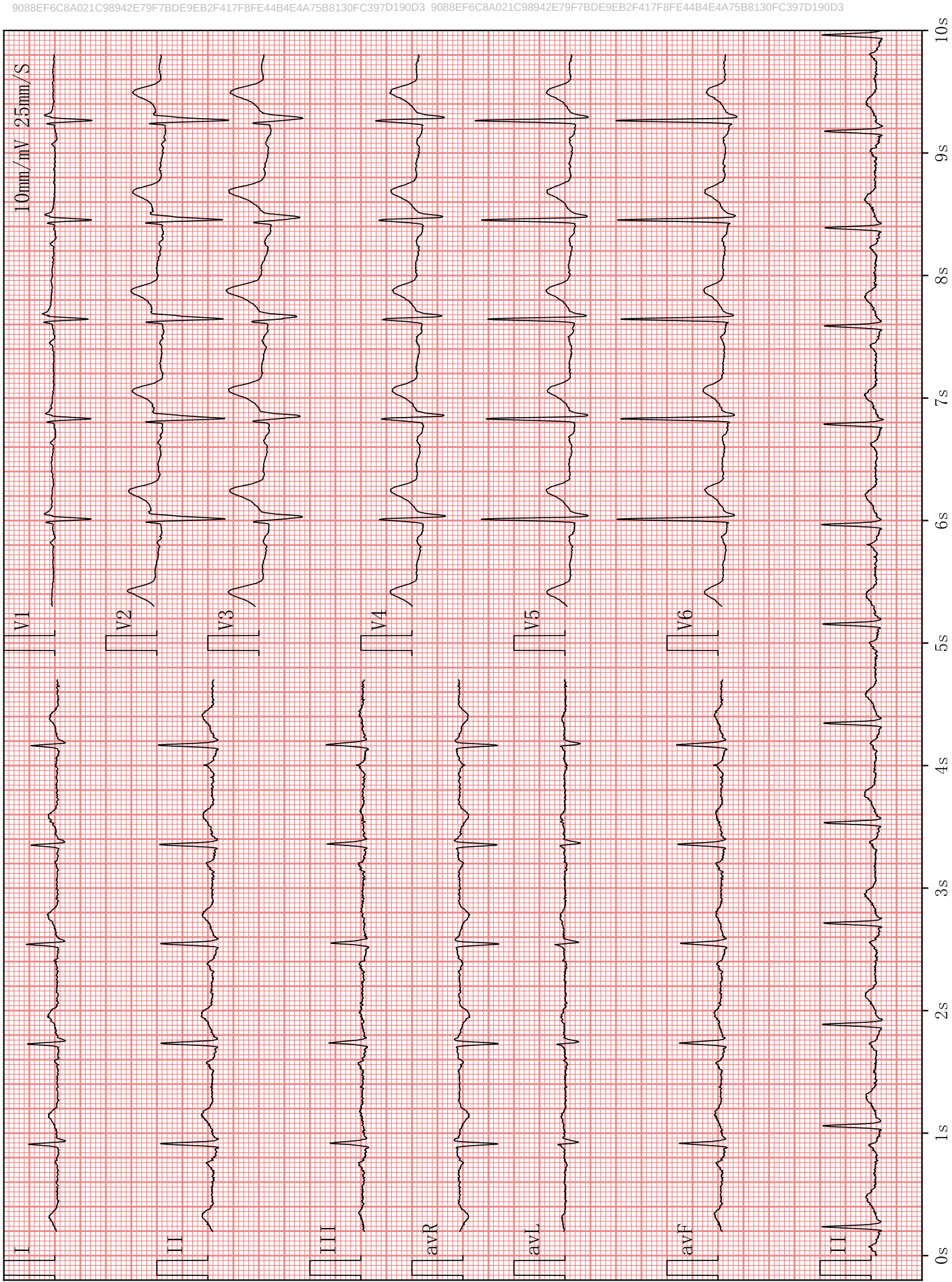
构。

指肝脏内脂肪含量增多，过度充积于肝细胞内超过正常范围。脂肪充盈于肝细胞内可减弱其功能，易受亲肝性毒物所损害，甚至发展为肝硬化。脂肪肝为可逆性，在合理治疗后可恢复正常。因此早期诊断有重要临床意义。大多数脂肪肝患者没有症状。有些患者可感觉疲劳、不适或右上腹不适。B超、CT有辅助诊断意义，确诊必须依靠肝活检。脂肪肝形成原因包括饮食不当、长期大量饮酒、过度肥胖等。防治脂肪肝主要靠调整饮食习惯和结

体检号:9320230401273

客户信息:刘小华/男/46

HR:73bpm PR:0.179s QTc:417 RV5/SV1:1.82mV/0.75mV
RR:0.812s QT:0.376s R+S:2.57 P/QRS/T轴:0°/66°/79°



9088EF6C8A021C98942E79F7BDE9EB2F417F8FE44B4E4A75B8130FC397D190D3 9088EF6C8A021C98942E79F7BDE9EB2F417F8FE44B4E4A75B8130FC397D190D3

检查者

刘小华